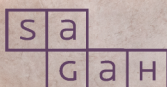


GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Gêsis Graziela Julião



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Redes e referências para os serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar as redes prioritárias em saúde e suas diretrizes.
- Questionar os processos de trabalho e a gestão na saúde e suas relações com a estrutura do sistema de saúde.
- Analisar as principais linhas de cuidado existentes e relacioná-las a indicadores de saúde.

Introdução

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram criadas como forma de organização dos serviços em arranjos que facilitam o fluxo dos usuários pelos diferentes níveis de atenção, além de nortear os profissionais de saúde com vistas a ofertar uma assistência integral e resolutive.

Além das RAS, as linhas de cuidado também são fundamentais para permitir que os princípios de universalidade, equidade e integralidade sejam atingidos, bem como para que os profissionais consigam agir de forma antecipada diante dos riscos identificados, promovendo a saúde, minimizando os danos, tratando e reabilitando quando necessário.

Neste capítulo, você vai conhecer as principais RAS do Sistema Único de Saúde (SUS), suas diretrizes e seu público-alvo. Além disso, vai ver como se dá o processo de trabalho dos serviços de saúde que compõem essas redes e a sua gestão, considerando as três esferas de gestão do SUS, e vai conhecer a relação das principais linhas de cuidado com os indicadores de saúde.

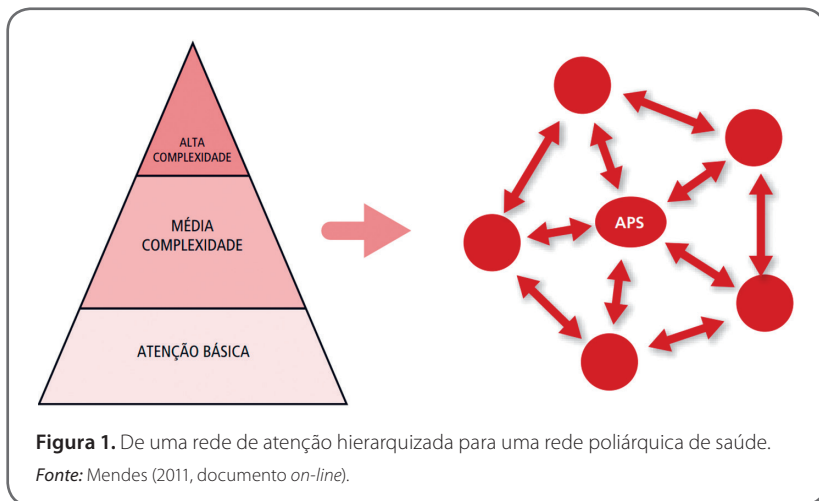
1 Redes prioritárias em saúde e suas diretrizes

As RAS se caracterizam pela organização dos serviços de saúde, de forma sistematizada, tendo como objetivo a oferta de maior acesso aos usuários dos serviços, resolutividade das ações, agilidade nos encaminhamentos, integralidade e longitudinalidade do cuidado, além de melhora na comunicação entre os diferentes níveis de atenção.

A porta de entrada preferencial do usuário no sistema de saúde brasileiro é a Atenção Primária à Saúde (APS), reconhecida pelos serviços das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que devem ordenar o cuidado do usuário por todos os demais serviços da RAS que forem necessários ao longo de seu tratamento, pois é o ponto da rede que está mais próximo do usuário e desenvolve vínculo com ele.

As atenções secundária e terciária são outros pontos da RAS responsáveis pelo atendimento de casos mais complexos — por meio do uso de maior densidade tecnológica e profissionais especializados — e correspondem aos serviços de urgência e emergência, às instituições hospitalares, entre outros.

Anteriormente, a RAS era representada pela figura de um triângulo, em que os serviços de atenção primária ou baixa complexidade ficavam na base da figura, os serviços de atenção secundária ou média complexidade no meio e os de atenção terciária ou alta complexidade, altamente especializados, no topo — sinalizava, assim, de forma rígida, o caminho que o usuário deveria percorrer no sistema de saúde. Contudo, a partir do entendimento dos princípios do SUS, que preza por horizontalidade, longitudinalidade, integralidade, equidade e universalidade da atenção, as redes passaram de hierarquizadas para redes poliárquicas (Figura 1), em que a APS está no centro — continua sendo a porta de entrada preferencial —, mas pode encaminhar o usuário para qualquer outro ponto da RAS (e os demais pontos também podem referenciar o usuário entre si).



Os principais objetivos da RAS são promover a saúde, prevenir o agravamento, ofertar ações reabilitadoras, curativas e paliativas por meio da garantia de uma assistência qualitativa com utilização dos recursos de forma adequada que resulte em melhora na qualidade de vida da população e na sustentabilidade do sistema (BOUSQUAT *et al.*, 2017).

A Portaria nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), estabeleceu as diretrizes para a organização da RAS no âmbito do SUS, visando desfragmentar as ações e os serviços de saúde, desencorajar o modelo médico centrado e qualificar a gestão do cuidado diante dos desafios do cenário atual, caracterizado pela diversidade social, econômica e cultural entre as regiões brasileiras. Além disso, a oferta de serviços privados faz uma grande pressão no mercado de saúde, exigindo que os serviços públicos atinjam cada vez mais qualidade e resolutividade em suas ações.

Outro ponto a se considerar é o perfil epidemiológico do Brasil, que engloba doenças parasitárias, infecciosas, desnutrição, ao mesmo tempo que há uma elevação constante nos números de obesos e de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis devido a hábitos de vida não saudáveis (BRASIL, 2010). Além dessas, ainda existe a alta prevalência de atendimento devido a causas externas, como violência e acidentes de trânsito, o que exige do sistema de saúde

a capacidade de atender os casos crônicos e agudos com a mesma qualidade e resolutividade. Segundo Santos (2017), para garantir a resolutividade das RAS, é importante definir e organizar os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade.

A superação dos desafios existentes e o avanço na qualificação da assistência à saúde exigem dos gestores um olhar crítico e uma visão de futuro necessárias para organizar o sistema de saúde. Assim, a forma de organização do sistema precisa considerar os aspectos técnicos, éticos, culturais, e financeiros de cada instância do governo. O que se espera é que a inovação do processo de articulação da RAS resulte em um impacto positivo nos indicadores de saúde da população (BRASIL, 2010).

O Pacto pela Saúde de 2006, firmado entre os gestores das três esferas do governo, ressalta a importância de regionalizar e organizar os serviços de saúde em redes para atingir e consolidar os princípios de universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 2006). Esse pacto é firmado em três dimensões: o Pacto Pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.



Saiba mais

O Pacto pela Vida define as prioridades de ação considerando a situação de saúde da população, o Pacto em Defesa do SUS busca a consolidação dos princípios do SUS na assistência à saúde e o Pacto de Gestão, por sua vez, firma “[...] o compromisso com a descentralização, a regionalização, o financiamento, o planejamento, a regulação, a participação social, além da gestão do trabalho e da educação em saúde” (BRASIL, 2010, documento *on-line*).

A Portaria nº. 4.279/2010 ainda define as seguintes redes prioritárias de atenção à saúde (BRASIL, 2010):

- Rede Cegonha;
- Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE);
- Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
- Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência;
- Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

A partir das RAS apresentadas, foram propostas as seguintes diretrizes para orientar as suas implantações e ações (BRASIL, 2010):

- fortalecimento da APS enquanto coordenadora do cuidado e ordenadora da RAS;
- integração das ações com a vigilância em saúde para gerenciar os riscos e os agravos à saúde;
- política de gestão do trabalho e da educação na saúde nas RAS;
- implementação de um sistema de planejamento, logístico e de apoio para o desenvolvimento das RAS, observando o financiamento do sistema de saúde para a consolidação dessas redes.

As diretrizes, portanto, são utilizadas como um guia de prática ou protocolo assistenciais para os profissionais dos diferentes níveis de atenção, orientando, ainda, as linhas de cuidado e viabilizando a comunicação entre as equipes e os serviços, a programação de ações e a padronização dos recursos que devem ser utilizados.

2 Processos de trabalho, gestão da saúde e suas relações com a estrutura dos sistemas de saúde

O SUS busca um modelo de atenção que garanta a integralidade do cuidado ao usuário ancorado nos seus princípios doutrinários. A implantação das RAS é resultado dessa busca e de vários fatores históricos e sociais analisados ao longo dos anos e foi uma forma de vincular os serviços de saúde e os gestores em benefício do usuário, já que essas redes beneficiam o desenvolvimento da clínica ampliada, a incorporação de programas e de políticas nacionais de saúde.

A organização da assistência em redes de atenção facilita o entendimento do usuário sobre os serviços que o acompanham, do profissional de saúde para realizar a referência e contrarreferência de forma correta, favorecendo a comunicação, e dos gestores para a solicitação e para o investimento dos recursos humanos, financeiros e materiais de acordo com as demandas e características de sua região. Além disso, é necessário ampliar as ações desenvolvidas para além das doenças, entendendo quais situações ou condições aumentam a vulnerabilidade das pessoas daquele território.

As linhas de cuidado existentes dentro da RAS têm o papel de definir o fluxo dos usuários e nortear os profissionais de maneira assertiva, definindo quais ações de saúde devem ser desenvolvidas em cada nível de atenção e nos sistemas de apoio para assegurar a qualidade, aumentar a eficiência, minimizar os erros dos profissionais e serviços e aumentar o grau de autonomia e a corresponsabilização do usuário, fornecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para promover a sua saúde. São capazes, ainda, de fornecer subsídios para o planejamento, programação e avaliação dos gestores, principalmente com relação a quantos e quais tipos de serviços assistências são necessários para atender as demandas de saúde da população.

O principal objetivo das linhas de cuidado é coordenar o fluxo assistencial do usuário por meio do arranjo e da contratualização de serviços que garantirão o cuidado integral do usuário. Os sistemas de informação são uma ferramenta chave nesse processo, pois é partir deles que é possível uma comunicação entre os profissionais de diferentes serviços sobre o mesmo paciente. Esses sistemas podem ser informatizados e integrados à rede de cada município, ou físicos, por meio de referência e contraconferência de papel. O importante é que seja um sistema de apoio à comunicação e de integração dos serviços dos diferentes níveis de atenção.

As linhas de cuidado são uma resposta da gestão das três esferas do governo na superação das respostas fragmentadas que ocasionavam danos ao sistema e à saúde do indivíduo. Como porta de entrada preferencial da RAS e nível básico da atenção, a APS deve ser o ponto inicial das diferentes linhas de cuidado. Cabe à gestão, por sua vez, assegurar os recursos materiais e humanos para que as ações da linha se concretizem.

O estudo da situação de saúde da população e a estratificação dos riscos dos grupos e coletividades relacionados aos fatores e condições a que estão expostos são ferramentas de gestão poderosas para a organização da prestação de cuidado, seja ele preventivo, promocional ou assistencial, uma vez que permitem a gestão da condição de saúde, da lista de espera e a realização da auditoria clínica a partir de uma abordagem baseada na população do território, com foco na promoção da saúde e na intervenção precoce para alcançar melhores resultados com menores custos (BRASIL, 2010).

A Figura 2 mostra um exemplo de linha de cuidado do HIV/Aids na Atenção Básica, desde a chegada do cliente na UBS, seguida de análise de fatores de risco, aconselhamento, oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais e seu fluxo na rede de acordo com o resultado. Se o resultado for não reagente, deve-se avaliar a necessidade de profilaxia pós-exposição (PEP) e continuar acompanhamento na UBS, realizando novo teste em 30 dias. Se o resultado for reagente, notifica-se pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), encaminha-se para consulta médica e para o SAE para compartilhar o tratamento com a UBS.

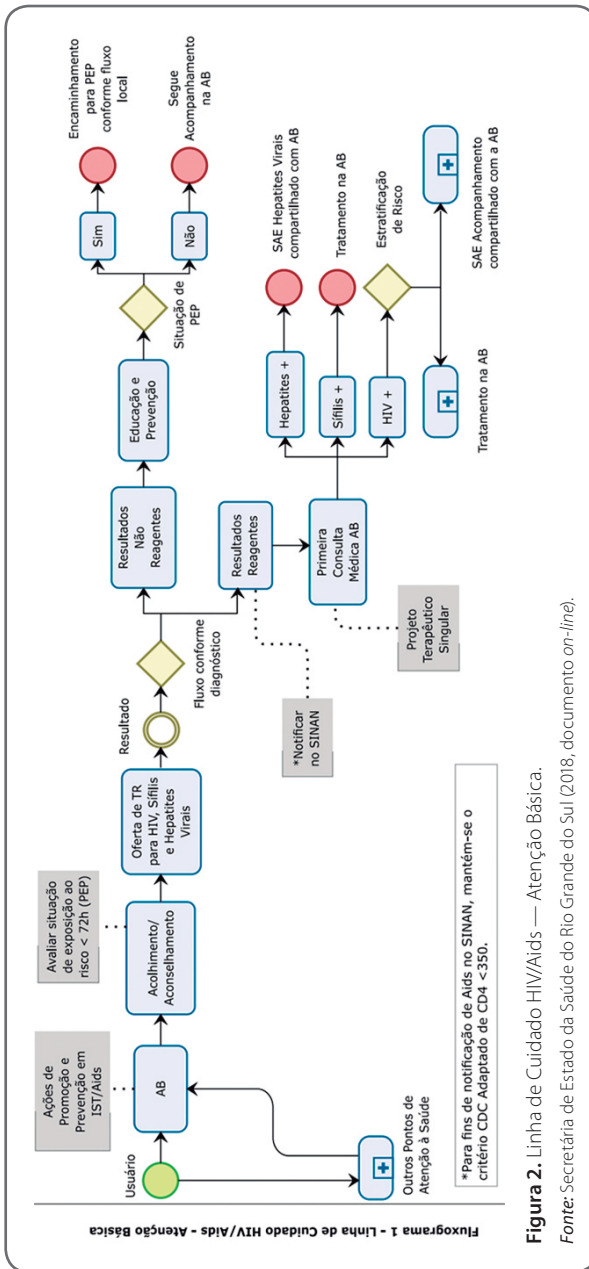


Figura 2. Linha de Cuidado HIV/Aids — Atenção Básica.

Fonte: Secretária de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (2018, documento *on-line*).

Os serviços da RAS que compõem a linha de cuidado do HIV/Aids devem estar estruturados e organizados para proporcionar um cuidado integral ao usuário, envolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, cuidado contínuo e longitudinal e reabilitação quando necessário (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2018). No exemplo apresentado, passamos pelo nível primário e secundário da atenção, conforme o que preconiza o Ministério da Saúde. O HIV, as hepatites virais e a sífilis podem ser tratados e acompanhados a nível ambulatorial, principalmente nos casos em que o diagnóstico é feito de forma precoce. No entanto, é possível que o paciente, em algum momento, necessite de atendimento no nível terciário, podendo ou não estar relacionado ao HIV/Aids, a hepatites virais ou sífilis; nesses casos, a comunicação entre os serviços deve estar alinhada para proporcionar um atendimento humanizado e adequado às necessidades do paciente.

As RAS e as linhas de cuidado possibilitam uma atenção integral ao paciente, com qualidade e com custos compatíveis de acordo com as evidências científicas e podem ser entendidas como uma forma de coordenar os processos que envolvem determinada condição de saúde ou doença — desde seu diagnóstico até sua reabilitação. Além disso, incluem a gestão dos riscos individuais e coletivos e passam pela análise do ambiente onde o indivíduo está inserido, pelas ações de vigilância — em que o foco é a identificação precoce de agravos de saúde da população, suas causas e fatores desencadeantes — para propor medidas de controle e eliminação dos riscos de forma assertiva (BRASIL, 2010).



Fique atento

Cabe ao gestor o planejamento, a monitorização e a avaliação das ações e serviços oferecidos, de acordo com a demanda apresentada, visando, sempre, a oferta de qualidade, a humanização e a resolutividade. Portanto, deve (BRASIL, 2010):

- atender as expectativas dos usuários;
- garantir o serviço certo ao usuário certo e no tempo certo;
- ampliar a qualidade da assistência ofertada;
- minimizar a fragmentação dos diversos serviços da RAS.

3 Principais linhas de cuidado e sua relação com os indicadores em saúde

Para que a RAS funcione como uma rede integralizada da atenção à saúde, sendo capaz de atender as diferentes demandas das pessoas, necessita de serviços com distintas complexidades de atuação. Uma forma de garantir a conversa entre os serviços, além da referência e da contrarreferência, é a partir do desenho de fluxos das linhas de cuidado em saúde, que perpassam os três níveis de atenção e garantem um atendimento integral do indivíduo. A seguir, você confere as principais redes, estruturadas com base nos agravos de saúde mais presentes na população brasileira.

Rede de Atenção à Urgência e Emergência (RUE)

A partir da implantação da Política Nacional de Atenção à Urgências e Emergência, as ações da RUE ficaram mais bem definidas no contexto da RAS e incluem todos os níveis de complexidade, desde o primário até o terciário, ou seja, desde as UBS, Atenção Domiciliar Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), até Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospital. Seu objetivo é integrar e articular esses serviços para garantir um acesso a assistência à saúde nos casos de urgência e emergência (BRASIL, 2011a).

A RUE é regulamentada pela Portaria nº. 1.600, de 7 de julho de 2011 (BRASIL, 2011a), que orienta que a atuação dos serviços seja conjunta e interdependente, respeitando o nível de complexidade de cada setor. Trata-se de uma estratégia importante para a consolidação do SUS no Brasil.

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Em 23 de dezembro de 2011, foi publicada a Portaria nº. 3.088 (BRASIL, 2011b), que regulamentou a rede de serviços para atender pessoas que apresentam sofrimento ou transtorno psíquico, além de dependência química de drogas lícitas ou ilícitas. Vários são os serviços que compõem essa rede de atenção, desde a APS até a instituição hospitalar, passando pelos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), pelas clínicas e fazendas de reabilitação de

dependentes químicos e pelos leitos hospitalares específicos. A equipe de atuação da RAPS, necessariamente, é multiprofissional para garantir um cuidado integral e a ressocialização do paciente. Os princípios que norteiam a RAPS são ética, respeito, cidadania, facilidade de acesso, cuidado qualificado, e abrangência.



Saiba mais

Os CAPS são classificados em CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad (BRASIL, 2011a).

- Os CAPS I são destinados ao atendimento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes em municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes.
- Os CAPS II atendem municípios com mais de 50 mil habitantes.
- Os CAPS III têm características condizentes com o atendimento de municípios com mais de 200 mil habitantes e podem funcionar em tempo integral — os usuários são os mesmos do CAPS I e II.
- O CAPSi tem como público-alvo crianças e adolescentes com transtornos mentais e pode ser implantado em municípios com mais de 200 mil habitantes.
- Os CAPSad são específicos para atendimento de pessoas que abusam do uso de drogas lícitas ou ilícitas, incorporados a RAPS em municípios com mais de 200 mil habitantes.

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (RASPDC)

Nas últimas décadas, o número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis vem aumentando consideravelmente, o que é reforçado pelo aumento da expectativa de vida e pelos hábitos de saúde não saudáveis da população (facilidade do acesso a alimentos industrializados, sedentarismo e abuso de tabaco e álcool são alguns deles). O foco do Ministério da Saúde (MS) é atuar sobre doenças renais, respiratórias, cardiovasculares, hipertensão, diabetes, neoplasias e obesidade com ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e ampliação da qualidade de vida destas pessoas.

A Portaria nº. 483, de 01 de abril de 2014 (BRASIL, 2014), regulamenta a RASPDC e define como objetivo capacitar os profissionais de saúde para qualificar a assistência ofertada nos diferentes níveis de atenção às pessoas

que vivem com doenças crônicas, a fim de reduzir as comorbidades e os óbitos em decorrência de complicações. A partir da RASPCD, o MS também criou o programa Academia da Saúde, o programa Saúde na Escola e o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Como as demais RAS, a APS constitui assistência primordial para o bom fluxo da RASPCD.

Rede Cegonha (RC)

Em 24 de junho de 2011, o Ministério da Saúde, com o objetivo de reduzir de forma esmagadora o número de óbitos maternos e neonatais, implantou a Rede Cegonha (BRASIL, 2011c). A partir da RC, foi confeccionado um novo modelo de atenção para o pré-natal, parto, puerpério e para criança até dois anos de idade. Entre as ações, estão planejamento familiar, classificação de risco da gestante e encaminhamento para realização de pré-natal de alto risco em serviço especializado, no mínimo 6 consultas de pré-natal, transporte seguro, humanização do parto, direito a acompanhante de escolha da gestante durante o trabalho de parto e parto, oferta de UTI adulta e neonatal e puericultura. A RC também preconiza a redução do número de cesáreas sem indicação clínica, capacitando profissionais e orientando as gestantes sobre os riscos e complicações de uma cirurgia sem necessidade.

Rede de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCPD)

Regulamentada pela Portaria nº. 793, de 24 de abril de 2012 (BRASIL, 2012), a RCPD é destinada ao cuidado integral de pessoas com deficiência e preconiza a implantação de Centros Especializados de Reabilitação (CER), destinados à oferta de assistência aos usuários com problemas de origem auditiva, física, intelectual e visual, visando extinguir as barreiras existentes no sistema de saúde e criar vínculos entre os diferentes serviços da rede de atenção e os usuários.

Para a consolidação de todas essas redes de atenção, é necessário que a referência e a contrarreferência entre os profissionais dos diferentes serviços que compõem o sistema de saúde nos três níveis de atenção, nos serviços de apoio e na gestão estejam bem articuladas e funcionem de forma eficaz. Esse é um dos maiores desafios para o SUS atingir sua potência de atuação em prol dos brasileiros.



Referências

BOUSQUAT, A. et al. Atenção primária à saúde e coordenação do cuidado nas regiões de saúde: perspectiva de gestores e usuários. *Ciênc. Saúde Coletiva*, v. 22, nº. 4, p. 1141-1154, abr. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002401141&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. *Diário Oficial da União*, Brasília, 22 fev. 2006. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 483, de 1º de abril de 2014. Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. *Diário Oficial da União*, Brasília, 1 abr. 2014. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0483_01_04_2014.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, 24 abr. 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. *Diário Oficial da União*, Brasília, 24 jun. 2011c. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, 7 jul. 2011a. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 3.088, de 23 de dezembro de 2011(*). Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, 23 dez. 2011b. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Portaria nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, 30 dez. 2010. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em: 30 abr. 2020.

MENDES, E. V. *As redes de atenção à saúde*. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. (E-book).

SANTOS, L. Região de saúde e suas redes de atenção: modelo organizativo-sistêmico do SUS. *Ciênc. Saúde Coletiva*, v. 22, nº. 4, p. 1281–1289, abr. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002401281&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 abr. 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. *Linha de cuidados para pessoas vivendo com HIV (PVHIV) e outras infecções sexualmente transmissíveis*. Porto Alegre: Escola de Saúde Pública, 2018. (E-book).



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS